**समक्ष: माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गाजियाबाद**

**विकास गांधी बनाम एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (ACKO General Insurance Ltd.)**

**विषय: एकमात्र शेष मतभेद के बिंदु पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण**

माननीय महोदय/महोदया,

इस मामले में एको (ACKO) और मेरे बीच लगभग सभी तथ्यों और मुद्दों पर सहमति है। केवल एक ही बिंदु ऐसा है जिस पर मेरा विनम्र निवेदन एको के रुख से भिन्न है:

**पॉलिसी अनुसूची (POLICY SCHEDULE) — पृष्ठ 36 / C-01**

*"जब तक कि दुर्दमता (Malignancy / कैंसर) के कारण आवश्यक न हो, जननांग प्रणाली (Genitourinary System) की किसी भी सर्जरी को कवर नहीं किया जाएगा।"*

**महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण:** मैं यह दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि बीएक्सओ (BXO) स्वयं में दुर्दमता (कैंसर) है।

**BXO ≠ दुर्दमता (Malignancy)**

हालाँकि, बीएक्सओ एक ऐसी स्थिति है जिसमें **चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत दुर्दमता / पेनाइल कैंसर (Penile Cancer) का जोखिम शामिल है**।

**चिकित्सीय रिकॉर्ड इसका समर्थन करते हैं**

- **बायोप्सी — अनुलग्नक C-09, पृष्ठ 98:** "लाइकेन स्क्लेरोसस (बालेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिटेरन्स) के अनुरूप" — BXO।

- **डॉ. वैभव सक्सेना, M.Ch. यूरोलॉजी (AIIMS), पृष्ठ 16:** उन्होंने इसे **"प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन (कैंसर से पूर्व की स्थिति)"** के रूप में प्रमाणित किया है; सर्जरी **"अनिवार्य थी"**, **"ऐच्छिक या कॉस्मेटिक नहीं"**; और स्पष्ट किया कि यदि इलाज न किया गया तो **"पेनाइल कैंसर का जोखिम"** था।

- **अस्पताल रिकॉर्ड — पृष्ठ 14:** "मूत्र का धीमा प्रवाह (POOR FLOW OF URINE)" और "मीटल स्टेनोसिस के साथ बालेनाइटिस और टाइट फिमोसिस" — यह पुष्टि करता है कि सर्जरी चिकित्सीय रूप से आवश्यक थी, कॉस्मेटिक या ऐच्छिक नहीं।

**बीमा लोकपाल (INSURANCE OMBUDSMAN) के निर्णय का महत्व** बीमा लोकपाल ने इस उपचार को **चिकित्सीय रूप से आवश्यक (MEDICALLY NECESSARY)** माना और स्थायी अपवर्जन क्लॉज 4.2.3 को लागू न होने योग्य पाया। उस स्तर पर पाई गई कमी मुख्य रूप से सर्जरी के बाद के मेडिकल दस्तावेजों से संबंधित थी। अब इलाज करने वाले विशेषज्ञ के प्रमाणपत्र द्वारा उस कमी को पूरा कर दिया गया है। — *लोकपाल निर्णय, पृष्ठ 115*।

मेरा प्रश्न यह **नहीं** है: *"क्या मुझे कैंसर था?"* — उत्तर: नहीं।

मेरा प्रश्न यह है: क्या एक **प्री-मैलिग्नेंट स्थिति**, जिसमें दुर्दमता (कैंसर) का चिकित्सीय रूप से स्वीकृत जोखिम मौजूद है और जिसके उपचार को विशेषज्ञ द्वारा आवश्यक प्रमाणित किया गया है, उसे पॉलिसी अपवाद *"जब तक कि दुर्दमता के कारण आवश्यक न हो"* को लागू करते समय पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है?

**कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम (CONTRA PROFERENTEM) — वैकल्पिक निवेदन** यदि पॉलिसी की शब्दावली में कोई वास्तविक अस्पष्टता पाई जाती है जिसके दो तर्कसंगत अर्थ निकल सकते हैं, तो **कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम** के सिद्धांत के अनुसार उस अस्पष्टता का अर्थ उस पक्ष के विरुद्ध निकाला जाना चाहिए जिसने पॉलिसी का प्रारूप तैयार किया है — यानी बीमा कंपनी — और बीमित व्यक्ति के पक्ष में। यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जहाँ वास्तविक अस्पष्टता मौजूद हो।

इसलिए, यदि आयोग को उपरोक्त अपवाद के दायरे में कोई वास्तविक अस्पष्टता मिलती है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि पॉलिसी की व्याख्या बीमित व्यक्ति के हित में की जाए।

**मेरा विनम्र प्रार्थना-पत्र** मैं एको (ACKO) से कोई नई शर्त बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतना अनुरोध कर रहा हूँ कि एको के अपने ही लिखित **पॉलिसी अपवाद** को मेरे मामले के वास्तविक चिकित्सीय तथ्यों पर लागू किया जाए।

**BXO ≠ दुर्दमता (Malignancy) → स्वीकृत दुर्दमता जोखिम → चिकित्सीय रूप से आवश्यक उपचार**

इसलिए, मैं आदरपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आयोग इस चिकित्सीय श्रृंखला और जहाँ लागू हो, **कॉन्ट्रा प्रोफेरेंटम** के सिद्धांत पर विचार करे, पॉलिसी अपवाद की उचित व्याख्या करे, और मेरे **₹37,358/-** के दावे के भुगतान का निर्देश दे।

धन्यवाद।

हाँ। मैंने Git repository में उपलब्ध **Courtroom Guide और उसमें ACKO के rejection/defence से संबंधित chronology और Ombudsman analysis** को देखकर, साथ में insurance-policy interpretation पर Supreme Court की current authorities को cross-check करके यह जवाब तैयार किया है।

सबसे पहले एक बात स्पष्ट: **Git repository में ACKO का कोई अलग, detailed written pleading/reply मुझे text-search में उपलब्ध नहीं मिला।** इसलिए ACKO का "exact pleading" quote करना उचित नहीं होगा। लेकिन आपकी file में दर्ज ACKO rejection और Ombudsman proceedings से उनका **actual position/inference** काफी साफ़ निकलता है।

**अगर Judge पूछें:**

**"ACKO का इस clause के बारे में क्या कहना है?"**

तो **बहस मत शुरू कीजिए। पहले बहुत शांत होकर यह कहिए:**

**"Sir, ACKO का मूल stand यह है कि मेरी surgery genitourinary system की surgery थी और policy में ऐसी surgery waiting period के अधीन है। ACKO का कहना है कि 'unless necessitated by malignancy' वाला exception मेरे case में लागू नहीं होता, क्योंकि मेरी biopsy में actual malignancy या cancer नहीं पाया गया था।**

**मैं इस point पर ACKO से पूरी तरह असहमत नहीं हूँ कि BXO स्वयं malignancy नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ।**

**मेरा limited point यह है कि BXO एक medically recognised pre-malignant condition है, जिसमें आगे penile malignancy का risk होता है, और मेरे treating specialist ने इसे specifically 'pre-malignant condition' बताया है तथा surgery को necessary बताया है।**

**इसलिए मेरा submission यह है कि इस medical evidence को केवल यह कहकर ignore नहीं किया जा सकता कि biopsy में established cancer नहीं था।**

**और यदि माननीय आयोग को policy wording में इस exception की interpretation को लेकर कोई genuine ambiguity दिखाई देती है, तो मैं alternative submission के रूप में contra proferentem का principle भी respectfully rely करता हूँ — अर्थात ambiguity, if any, should be construed against the insurer who drafted the policy and in favour of the insured."**

**लेकिन अगर Judge तुरंत पूछें:**

**"लेकिन clause में तो 'malignancy' लिखा है। BXO malignancy नहीं है। फिर exception कैसे लगेगा?"**

यह **सबसे कठिन सवाल** है। इसका जवाब बहुत carefully देना है:

**"Sir, बिल्कुल — BXO को मैं malignancy नहीं कह रहा हूँ।**

**मेरा submission यह नहीं है कि BXO = cancer.**

**मेरा submission यह है कि BXO एक pre-malignant condition है, और मेरे treating specialist ने specifically certify किया है कि untreated रहने पर penile cancer का risk था और surgery was must.**

**इसलिए मैं माननीय आयोग से उस medical evidence को policy exception की interpretation में consider करने का निवेदन कर रहा हूँ।**

**यदि माननीय आयोग यह मानता है कि 'malignancy' का केवल एक ही अर्थ — established cancer — हो सकता है, तो मैं उस interpretation को Commission के consideration के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन यदि clause और पूरे medical context को पढ़ने पर genuine ambiguity रहती है, तो contra proferentem के सिद्धान्त के अनुसार ambiguity को insured के पक्ष में resolve किया जा सकता है।**

**और मेरा independent point यह है कि surgery medically necessary थी, cosmetic या elective नहीं थी — जिसे hospital record, biopsy और treating specialist के certificate से support किया गया है।"**

**एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार**

मैं आपको **यह नहीं बोलने दूँगा**:

"ACKO मानता है कि malignancy exception है लेकिन वह मुझे नहीं देना चाहता।"

क्योंकि repository से ऐसा साफ़ admission सिद्ध नहीं होता।

ACKO का अधिक defensible position यह है:

**Genitourinary surgery → waiting-period clause → no established malignancy → exception unavailable.**

आपकी अपनी file में rejection की chronology भी इसी दिशा में है: ACKO ने **25.06.2025** को ही कहा कि condition malignancy से related नहीं है, जबकि histopathology report **30.06.2025** की है।

यही आपके लिए **बहुत महत्वपूर्ण factual attack** है।

आप Judge को यह कह सकते हैं:

**"Sir, the difficulty is that when ACKO rejected the claim on 25.06.2025 on the basis that it was not related to malignancy, the histopathology report establishing BXO had not even come into existence; it came on 30.06.2025."**

यह बात **"ACKO ने मेरी बात नहीं सुनी"** कहने से ज्यादा मजबूत है।

---

**और Ombudsman वाला point यहाँ बहुत काम आएगा**

आपके repository record के अनुसार Ombudsman ने:

- treatment को **medically necessary** माना;
- Permanent Exclusion Clause 4.2.3 को applicable नहीं माना;
- लेकिन उस समय available post-operative medical documentation के आधार पर claim reject किया।

इसलिए अगर Judge पूछें:

**"Ombudsman ने तो आपका claim reject कर दिया था?"**

आपका जवाब होना चाहिए:

**"Yes, Sir. The Ombudsman did not reject the case on the ground that the surgery was unnecessary. In fact, the decision records the treatment as medically necessary and did not apply the Permanent Exclusion Clause 4.2.3. The issue at that stage was the supporting post-operative medical documentation.**

**That gap has subsequently been addressed by the treating specialist's medical certificate, which is now on record and specifically records the condition as pre-malignant, the surgery as necessary, and the risk of penile cancer if untreated.**

**Therefore, I am respectfully requesting that the present Commission consider the complete medical record now available."**

**और अगर Judge पूछें — "तो आपका पूरा case किस एक बात पर है?"**

**बस यह तीन लाइन याद रखिए:**

**"Sir, I am not saying BXO is cancer.**
**I am saying BXO is a pre-malignant condition carrying a medically recognised risk of malignancy, and my treating specialist certified that the surgery was necessary.**
**Therefore, the medical evidence must be considered while interpreting the policy exception."**

यही आपका **सबसे साफ़, सुरक्षित और intellectually honest answer** है।

**Contra proferentem पर भी एक correction**

इसे **पहला हथियार नहीं**, बल्कि **alternative argument** ही रखें। Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि पहले insurance policy को **पूरे contract के साथ harmoniously interpret** किया जाता है; केवल genuine ambiguity बचने पर contra proferentem लागू होता है। (Sci API)

इसलिए courtroom sequence होना चाहिए:

**1. ACKO का stand acknowledge करो**
↓
**2. BXO ≠ malignancy — खुद concede करो**
↓
**3. BXO = recognised pre-malignant condition + cancer risk**
↓
**4. Specialist: surgery "was must"**
↓
**5. Hospital: poor urine flow + tight phimosis + meatal stenosis**
↓
**6. ACKO rejected before histopathology existed**
↓
**7. Ombudsman: medically necessary + permanent exclusion not applicable**
↓
**8. Complete medical evidence is now before Commission**
↓
**9. Only then: if genuine ambiguity remains → CONTRA PROFERENTEM.**

**यह structure मुझे आपके case के लिए वर्तमान one-page PDF से भी ज्यादा मजबूत लगता है**, क्योंकि इसमें आप ACKO की बात को गलत तरीके से represent नहीं कर रहे—पहले उनकी strongest position स्वीकार करते हैं और फिर उसी के ऊपर अपना narrower argument बनाते हैं।